

三型體質整合臨床培訓

九型三中心 × 理法方藥 × App 臨床落地

Eden TCM Clinic 醫師內訓

講者：[你的名字]

日期：[yyyy-mm-dd]

點解要做「同一語言」？

- 同症不同判，容易影響病人信任
- 覆診時方藥邏輯難追溯
- 病人教育內容未一致
- App 記錄未形成可比較數據

目標：建立可共享、可追蹤、可複盤的臨床框架。

三型體質框架總覽

- **[型A]**：[核心病機一句]
- **[型B]**：[核心病機一句]
- **[型C]**：[核心病機一句]
- 每位病人均標示：**主型 + 次型**

三型不是取代辨證，而是第一層臨床分流主軸。

[型A] 臨床入口

- 常見主訴：[例：失眠、胃口差、易焦慮]
- 四診關鍵：[舌脈與問診重點]
- 易見風險：[拖延治療／反覆發作]
- 首選方向：[理法方藥一句話]

提示：先抓最影響生活功能的主訴，再驗證是否與主軸一致。

[型B] 臨床入口

- 常見主訴：[例：疲倦、情緒波動、月經失調]
- 四診關鍵：[舌脈與問診重點]
- 易見風險：[過度補／過度攻]
- 首選方向：[理法方藥一句話]

提示：先排主次證，再做加減，避免每次改方過大。

[型C] 臨床入口

- 常見主訴：[例：痛症、脹悶、睡眠淺]
- 四診關鍵：[舌脈與問診重點]
- 易見風險：[只治標，忽略體質根底]
- 首選方向：[理法方藥一句話]

提示：同一追蹤指標連續觀察，避免誤判療效。

三中心如何接上中醫

- 頭中心（5/6/7）：風險預期、思慮負荷
- 心中心（2/3/4）：情志價值、關係壓力
- 腹中心（8/9/1）：控制忍壓、升降失衡
- 原則：**四診為本，三中心為輔**

三中心是「反應模式工具」，不是醫療診斷標籤。

門診判讀四步法

- 第一步：抓主訴軸線（功能受損最大）
- 第二步：看三中心反應（頭／心／腹）
- 第三步：合四診辨證（舌脈證據）
- 第四步：下主型/次型 + 理法方藥

重點：流程可重現，交接可延續，病人可理解。

常見誤判與修正

- 把人格當診斷 → 人格只作反應線索
- 只追症狀，不看體質 → 每次先定主/次型
- 每次加減太多 → 單次只改關鍵位
- 記錄不完整 → App 必填欄位標準化

判讀一致性 = 臨床質量穩定性。

9 份簡報路線圖

- PPT 1-3：三型 + 三中心基礎與轉譯
- PPT 4-7：理法方藥決策與病例模板
- PPT 8-9：App 記錄、病人教學、KPI 落地
- 本週行動：每位醫師先完成 1 例標準化記錄

同一語言、同一流程、同一質量，先可以穩定放大成果。